想定Q&A集

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

戦略会議 想定Q&A集（2025年度2月実績ベース）

作成日: 2026年3月28日
対象期間: 2025年度4月～2月（累計）および2月単月
対象病院: 大橋病院（3病院比較含む）
作成部署: 経営企画部

---

1. 収支・予算関連（7問）

Q1-1. 今年度の診療収入は予算に対してどの程度の乖離があるのか。年度末の着地見通しはどうか。

【結論】
累計で約3.2億円の予算未達（予算対比97.9%）であり、年度末には約3.5億円程度の未達で着地する見通しである。

【根拠データ】
・資料1-1：診療費総額（入院+外来）累計 14,818,646千円に対し、予算15,141,036千円、差額 △322,390千円（予算対比97.9%）
・入院：累計9,644,523千円 vs 予算9,673,981千円（△29,458千円、99.7%）
・外来：累計5,174,123千円 vs 予算5,467,055千円（△292,932千円、94.6%）
・外来の予算未達が全体の約91%を占めている

【補足/対策】
外来収入の未達が主因である。外来患者数が予算比で月平均55.9人少ない（資料1）ことが最大の要因。3月の挽回だけでは累計の乖離を埋めることは困難であり、来年度予算策定時に外来患者数の前提を見直す必要がある。

Q1-2. 外来収入が予算を大幅に下回っている原因は何か。

【結論】
一日平均外来患者数が予算比で大幅に減少していることが主因。ただし、外来単価は予算を上回っている。

【根拠データ】
・資料1-1：一日平均外来患者数 累計852.1人 vs 予算910.0人（△57.9人）
・資料1：大橋病院 外来一日平均患者数 累計851.6人 vs 予算907.5人（△55.9人、△6.2%）
・一方、外来単価は累計22,628円 vs 予算22,647円とほぼ予算並み（資料1）
・資料1-1：初診患者数 累計16,688人 vs 前年度18,134人（△1,446人、△8.0%）
・資料7-2：紹介件数 累計12,652件 vs 前年度15,022件（月平均△102件）

【補足/対策】
初診患者の減少（前年度比△1,446人）と紹介件数の減少（月平均1,150件 vs 前年度1,252件）が患者数減の主因。資料10によると紹介患者数の目標は月1,300件に対し実績は月平均1,150件と未達。地域連携強化、医師による医療機関訪問の継続（現在月平均10.5件）、紹介元医療機関への積極的なアプローチが必要。

Q1-3. 大橋病院の粗利益が予算を大幅に下回っているが、どう認識しているか。

【結論】
4～2月累計の粗利益は122,991千円で、予算552,078千円に対して△429,087千円（△77.7%）と極めて深刻な状況である。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 累計 粗利益122,991千円 vs 予算552,078千円（△429,087千円）
・粗利益率：0.8% vs 予算3.4%（△2.6ポイント）
・収入面：収入合計 15,841,950千円 vs 予算16,153,885千円（△311,935千円、△1.9%）
・支出面：支出合計 15,718,959千円 vs 予算15,601,807千円（+117,152千円、+0.8%）
・特に人件費支出が予算比+105,674千円（+1.6%）と超過

【補足/対策】
収入減と支出増の双方が粗利益を圧迫している。収入は外来の△341,216千円（△6.2%）が最大。支出では人件費が予算を1.6%上回っている。医療経費も+103,650千円。コスト管理の強化と収入増加策の両面からの対応が急務。

Q1-4. 基本金組入前当年度収支差額が大幅な赤字となっているが、改善策はあるのか。

【結論】
大橋病院の基本金組入前当年度収支差額は累計△1,376,980千円と、予算△906,788千円から△470,192千円の悪化。賞与引当金含みでは△1,924,610千円と深刻。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 累計 基本金組入前当年度収支差額 △1,376,980千円（予算比 △470,192千円、△51.9%）
・賞与引当金繰入額含む：△1,924,610千円（前年度差 △714,767千円）
・2月単月：18,323千円（予算66,409千円に対し△48,086千円）

【補足/対策】
事業活動収支項目他（減価償却費等）の影響が大きい。減価償却額は月平均約113,160千円と経年的に増加傾向。設備投資計画の見直しと収入増加の両面での対策が必要。来年度に向けて投資対効果の厳密な検証を実施すべき。

Q1-5. 査定率・査定額が目標を上回っているが、具体的な対策は。

【結論】
査定率は累計平均0.54%で目標0.40%を上回り、査定額も累計74,349千円で目標55,000千円を大幅に超過している。

【根拠データ】
・資料10：査定率 平均0.54% vs 目標0.40%
・査定額 累計74,349千円 vs 目標55,000千円（年間ベース）
・特に7月0.86%、8月0.77%と高い月があった

【補足/対策】
診療科へのヒアリングとフィードバックを実施中（資料10記載）。高査定率の診療科を特定し、レセプト点検の強化、算定ルールの再教育を行う。12月は0.44%と目標値まで改善しており、直近の取組み効果は出始めている。

Q1-6. 入院収入は予算をほぼ達成しているように見えるが、安心してよいのか。

【結論】
累計で予算対比99.7%と一見堅調だが、4月の大幅黒字（+94,175千円）を除くと5月以降は概ね予算割れが常態化しており、楽観視できない。

【根拠データ】
・資料1-1：入院診療費 累計9,644,523千円 vs 予算9,673,981千円（△29,458千円）
・月別予算対比：4月111.0%以外は、95.6%～104.9%で推移し、10月以降は95.6%→96.2%→97.6%→95.9%→99.6%と低迷
・病床稼働率 累計88.9% vs 予算92.0%（△3.1ポイント）

【補足/対策】
入院単価は累計101,517円で予算98,511円を上回っている（+3,006円）が、病床稼働率の低さ（88.9%）が患者数を押し下げている。ベッドコントロールの更なる強化が必要。

Q1-7. 入院単価が前年度を上回っているのは評価できるが、持続可能か。

【結論】
入院単価は累計101,517円で前年度97,592円から+3,925円と改善。DPC期間II以内退院率や特定入院料算定率の改善が寄与しており、一定の持続性はある。

【根拠データ】
・資料1-1：入院単価 累計101,517円 vs 前年度97,592円（+3,925円）
・資料1：大橋 入院一日一人当たり診療額 累計100,719円 vs 前年度96,652円（+4,067円、+4.2%）
・資料10：DPC期間II以内退院割合 71.9%（目標70.0%達成）
・資料4：ICU算定率 79.6%（前年71.5%から+8.1ポイント改善）

【補足/対策】
平均在院日数の短縮（8.9日、前年度9.2日）と特定入院料算定率の改善が単価向上に寄与。引き続きクリニカルパスの活用（使用率65.1%で目標60%達成）や入退院支援の強化で維持可能と考える。

---

2. 入院部門関連（4問）

Q2-1. 病床稼働率が目標92%に対して88.9%と低迷している原因は何か。

【結論】
7月～10月に85～87%台まで落ち込んだことが年間平均を押し下げている。新入院患者数は前年度を上回っているが、在院日数短縮が稼働率を押し下げている。

【根拠データ】
・資料1-1：病床稼働率 累計88.9% vs 予算92.0%（△3.1ポイント）
・月別推移：7月86.8%→8月86.8%→9月85.9%→10月86.7%（4か月連続87%未満）
・一方、2月は94.0%と高稼働を達成
・新入院患者数 累計9,595人 vs 前年度9,359人（+236人）
・平均在院日数 8.9日 vs 前年度9.2日（△0.3日短縮）

【補足/対策】
在院日数短縮は効率性係数向上に寄与するが、稼働率と相反する。新入院患者をさらに増やすことで稼働率を維持する戦略が必要。資料10の退院前日15時退院決定割合は83.7%（目標80%達成）と改善しており、ベッドコントロールの仕組みは機能している。

Q2-2. 平均在院日数が短縮しているが、効率性係数にどう影響しているか。

【結論】
平均在院日数は8.9日（前年度9.2日）と目標9.0日を達成しており、効率性係数の改善に貢献している。

【根拠データ】
・資料1-1：平均在院日数 累計8.9日 vs 予算9.0日 vs 前年度9.2日
・資料10：DPC期間II以内退院割合 71.9%（目標70.0%、前年度70.0%から改善）
・予定入院のDPC期間II以内退院割合 77.5%（目標75.0%達成）
・緊急入院のDPC期間II以内退院割合 60.4%（目標60.0%達成）

【補足/対策】
手術あり患者のDPC期間II以内退院割合は75.3%（目標70%）と高い。手術なし患者は66.1%（目標70%に未達）であり、内科系疾患の退院支援強化が課題。

Q2-3. 特定入院料病棟（ICU/HCU/SCU）の算定状況はどうか。

【結論】
ICUとSCUは前年度から大幅に改善。HCUは稼働率が一時低下したが2月に回復。

【根拠データ】
・資料4/資料10：
  ・ICU：算定率79.6%（前年度71.5%、+8.1pt）、稼働率87.4%（目標80%達成）、金額累計197,549千円（前年度比+20,947千円）
  ・HCU：算定率73.4%（前年度72.9%、+0.5pt）、稼働率80.9%（目標80%達成）、2月は91.4%と年度最高
  ・SCU：算定率95.6%（前年度90.2%、+5.3pt）、稼働率95.8%（目標90%達成）

【補足/対策】
ICUの改善が顕著で、金額ベースで年間約2,100万円の増収効果。一方、HCUは9月に稼働率67.5%まで低下した時期があり、安定的な患者確保が課題。SCUは100%超の月もあり、病床不足の可能性も検討すべき。

Q2-4. 入退院支援加算の算定状況は改善しているか。

【結論】
入退院支援加算は累計3,116件（月平均283.3件）で、前年度比+147件と着実に増加している。

【根拠データ】
・資料8：入退院支援加算 累計3,116件（月平均283.3件）vs 前年度2,969件（月平均271.0件）
・金額：累計24,574千円（月平均2,234千円）vs 前年度25,896千円（月平均2,158千円）→月平均では増加
・退院患者における割合：32.4%（前年度34.0%からやや低下）
・入院時支援加算：累計1,047件（月平均95.2件）vs 前年度1,043件（月平均99.6件）
・介護支援連携指導料：過去12か月累計74件（施設基準要件48件を充足）

【補足/対策】
件数は増加しているが、退院患者に占める割合はやや低下。病棟別では7A病棟が月平均60.1件と最多で、4A病棟が41.5件。病棟間のばらつきを是正し、特に6B病棟（月平均29.1件）の底上げが課題。

---

3. 外来部門関連（4問）

Q3-1. 外来患者数が前年度を大きく下回っている。どう挽回するのか。

【結論】
一日平均外来患者数は852.1人で、前年度895.4人から△43.3人（△4.8%）と減少。紹介件数の減少と初診患者の減少が主因。

【根拠データ】
・資料1-1：一日平均外来患者数 累計852.1人 vs 前年度895.4人（△43.3人）
・初診患者数 累計16,688人 vs 前年度18,134人（△1,446人、△8.0%）
・初診率 7.4% vs 前年度7.8%（△0.4pt）
・資料7：紹介率 月平均85.9% vs 前年度87.1%（△1.2pt）
・資料7-2：紹介件数累計 2025年度各科合計で前年度比減少（整形外△543件が最大）

【補足/対策】
資料7-2によると、整形外科（前年度2,192→1,649件、△543件）、消化内科（2,574→2,291件、△283件）、耳鼻科（1,461→1,279件、△182件）の紹介減が大きい。紹介元医療機関別では明大前クリニック（△10件）をはじめ複数施設で減少。個別の関係強化施策が必要。

Q3-2. 外来単価は改善しているが、何が寄与しているのか。

【結論】
外来単価は累計22,841円で前年度21,551円から+1,290円（+6.0%）と改善。化学療法と高額薬剤の使用増が主な要因。

【根拠データ】
・資料1-1：外来単価 累計22,841円 vs 前年度21,551円（+1,290円）
・資料2：外来化学療法加算算定件数 累計2,939件 vs 前年度2,514件（+425件、+16.9%）
・外来化学療法金額 累計21,823千円 vs 前年度17,436千円（+4,387千円、+25.2%）
・資料1：大橋 外来一日一人当たり診療額 累計22,628円 vs 前年度21,439円（+1,189円、+5.5%）

【補足/対策】
外来化学療法の件数増加（特に外科：前年度1,338→1,481件、消化器内科：394→478件、泌尿器科：90→199件）が単価向上に大きく寄与。一日あたり予約患者数も12.7人と前年度10.6人から+2.1人増加。今後も化学療法室の効率的運用を継続する。

Q3-3. 紹介率・逆紹介率は地域医療支援病院の基準を満たしているか。

【結論】
紹介率85.9%、逆紹介率89.8%で、いずれも地域医療支援病院基準（紹介率80%・逆紹介率40%）を十分に満たしている。

【根拠データ】
・資料7：紹介率 月平均85.9%（基準(1)80%以上を達成）
・逆紹介率 月平均89.8%（基準(2)40%以上を大幅に達成）
・診療報酬算定要件の紹介割合 月平均97.2%（基準50%以上）
・逆紹介割合 月平均71.2パーミル（基準30パーミル以上）

【補足/対策】
基準は満たしているが、紹介率は前年度87.1%から△1.2pt低下。特に1月は82.7%と低下した月もある。紹介件数自体は前年度比で月平均△102件減少しており、紹介率の維持は初診患者数の減少に助けられている側面もある。実質的な紹介件数の増加が本質的な課題。

Q3-4. 紹介受入れの拒否状況はどうなっているか。改善できるのか。

【結論】
2月の紹介受入拒否は11件。「ベッド満床」が最多の理由で、特定の診療科に集中している。

【根拠データ】
・資料7-1：2026年2月の拒否11件の内訳
　・ベッド満床：7件（呼吸器2、消化器1、整形3、皮膚1）
　・処置困難（医師不在等）：3件（外科1、婦人科1、整形1）
　・対応困難：1件（整形1）
・整形外科関連の拒否が4件と最多
・過去12ヶ月で拒否率30%超かつ6件以上の施設は「あきもとクリニック」1件のみ

【補足/対策】
ベッド満床による拒否が主因であり、病床稼働率88.9%との矛盾は一時的な病棟別偏在が原因と考えられる。病棟横断的なベッドコントロールの強化と、特に整形外科病床の運用見直しが必要。

---

4. 3病院比較関連（5問）

Q4-1. 3病院の中で大橋病院の収支状況はどのような位置付けか。

【結論】
大橋病院は3病院中、粗利益率が最も低く（0.8%）、経営的に最も厳しい状況にある。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 粗利益率
　・大森病院：2.1%（粗利益760,402千円）
　・大橋病院：0.8%（粗利益122,991千円）
　・佐倉病院：0.5%（粗利益90,213千円）
・予算比の粗利益乖離
　・大森：△649,731千円（△46.1%）
　・大橋：△429,087千円（△77.7%）
　・佐倉：△1,623千円（△1.8%）

【補足/対策】
佐倉病院は粗利益率では大橋より低いが、予算との乖離は小さい（△1.8%）。大橋病院は予算との乖離が最も大きく（△77.7%）、予算策定の精度と収支改善の両面で課題がある。大森病院は規模のメリットで粗利益額は最大だが、予算比では△46.1%と未達。

Q4-2. 手術件数は3病院比較でどうか。大橋は増やせるのか。

【結論】
大橋病院の手術件数は累計5,857件で、前年度比+213件（+3.8%）と3病院中2番目に増加率が高い。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 手術件数
　・大森病院：11,931件（前年度比+406件、+3.5%）予算比+1,112件
　・大橋病院：5,857件（前年度比+213件、+3.8%）予算比+395件

・佐倉病院：5,704件（前年度比△201件、△3.4%）予算比+236件
・資料3：大橋病院 手術室件数 2025年度累計5,857件 vs 前年度5,644件
・外科：900件（前年度945件から△45件だが、4-2月比では+31件）
・産婦人科：294件（前年度256件から+38件、+14.8%）

【補足/対策】
急性期充実体制加算の施設基準（全麻2,000件/年以上、緊急手術350件/年以上）に対し、緊急手術は累計582件で基準値を上回る。外科・産婦人科の件数増が目立つ一方、整形外科は706件（前年度774件）とやや減少傾向。ダヴィンチ手術は月平均10.2件（目標10件達成、資料10）。

Q4-3. 外来患者数の減少は大橋病院だけの問題か。

【結論】
3病院すべてで外来患者数は前年度比・予算比ともに減少しており、大橋病院だけの問題ではない。ただし、大橋の減少幅が相対的に大きい。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 一日平均外来患者数（予算比）
・大森病院：1,940.1人（予算比△88.7人、△4.4%）
・大橋病院：851.6人（予算比△55.9人、△6.2%）←最大の乖離率
・佐倉病院：1,027.5人（予算比△49.5人、△4.6%）
・2月単月の新患者数（前年比）
・大森：142.0人（△13.4人、△8.6%）
・大橋：61.5人（△7.1人、△10.3%）←最大の減少率
・佐倉：60.3人（△10.4人、△14.7%）

【補足/対策】
外来患者減は法人全体の課題だが、大橋病院は予算比の乖離率が最大（△6.2%）。ただし外来単価は大橋22,628円（予算比△0.1%）と概ね維持できており、大森・佐倉は単価が予算を上回っている。患者数減をどこまで単価で補えるかが今後の鍵。

Q4-4. 3病院の人件費比率に問題はないか。

【結論】
大橋病院の人件費は予算を上回っており、収入に対する人件費比率が他院と比較しても高い水準にある。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 人件費支出（予算比）
・大森病院：14,237,155千円（予算比+6,515千円、+0.0%）
・大橋病院：6,519,108千円（予算比+105,674千円、+1.6%）←最大の超過率
・佐倉病院：7,170,706千円（予算比△256,855千円、△3.5%）
・収入に対する人件費比率（概算）
・大森：38.6%
・大橋：41.2%
・佐倉：39.6%

【補足/対策】
大橋病院は人件費率41.2%と3病院中最も高い。2月単月では440,637千円と予算406,385千円を34,252千円（+8.4%）上回った。佐倉が予算比△3.5%と人件費を抑制できていることとの対比が顕著。人員配置の最適化と労働生産性の向上が課題。

Q4-5. 大橋病院の入院単価は3病院中どのような位置付けか。

【結論】
大橋病院の入院単価は3病院中最も高く、収益性の面では強みと言える。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 入院一日一人当たり診療額
　・大森病院：94,747円（予算比+747円、+0.8%）
　・大橋病院：100,719円（予算比+2,208円、+2.2%）←最高
　・佐倉病院：85,521円（予算比△978円、△1.1%）
・大橋は予算比でもプラスであり、前年度比でも+4,067円（+4.2%）

【補足/対策】
大橋病院の入院単価の高さは、ICU/HCU/SCUの特定入院料算定率の改善（資料4）や、救急医療管理加算の適正算定（資料10）が寄与。平均在院日数の短縮（8.9日）も単価を押し上げる要因。この強みを活かしつつ、患者数を増やして収入総額を伸ばすことが重要。

---

5. 各部門（化学療法・手術・リハビリ等）関連（5問）

Q5-1. 外来化学療法の件数が大幅に増えているが、体制は十分か。

【結論】
外来化学療法加算の算定件数は累計2,939件（月平均267件）で前年度比+425件（+16.9%）と大幅増加。体制面の検討が必要な水準に達している。

【根拠データ】
・資料2：外来化学療法加算算定件数 累計2,939件 vs 前年度2,514件（+425件）
・金額：累計21,823千円 vs 前年度17,436千円（+4,387千円、+25.2%）
・一日あたり予約患者数：12.7人 vs 前年度10.6人（+2.1人）
・算定実患者数：月平均185人 vs 前年度170人（+15人）
・曜日別では水曜日（月平均70.5人）と木曜日（69.5人）に集中

【補足/対策】
水曜・木曜への集中が見られるため、他の曜日への分散が必要。10月は月320件と年度最高を記録。特に外科（累計1,481件、前年度+255件）と消化器内科（478件、+117件）、泌尿器科（199件、+120件）の増加が著しい。看護師配置やベッド数の再検討を推奨。

Q5-2. リハビリテーションの算定が前年度を下回っているが、原因は何か。

【結論】
リハビリ算定単位数は累計27,354単位で前年度28,621単位から△1,267単位（△4.4%）と減少。特に運動器リハと脳血管リハの減少が大きい。

【根拠データ】
・資料5：2025年度 算定単位数 累計27,354単位 vs 前年度28,621単位（△1,267単位）
・算定金額 累計61,875千円 vs 前年度64,480千円（△2,605千円、△4.0%）
・内訳（前年度差）：
　・脳血管リハ：10,929単位（前年度12,232、△1,303）
　・運動器リハ：9,838単位（前年度10,670、△832）
　・廃用リハ：2,115単位（前年度884、+1,231）←大幅増

・一日平均単位数：103.0単位 vs 前年度109.8単位（△6.8単位）

【補足/対策】
12月以降は回復傾向にあり（12月+283、1月+173、2月+482単位）、直近3か月は前年度を上回っている。廃用症候群リハは2倍以上に増加しており、高齢患者への対応強化の効果が出ている。脳血管・運動器リハの対象患者確保とスタッフ体制の充実が課題。

Q5-3. 放射線治療の算定が減少しているが、どう対応するのか。

【結論】
放射線治療の算定金額は累計121,884千円で前年度138,356千円（4-2月分推計）から約16,472千円の減少。ただし直近では回復傾向。

【根拠データ】
・資料9：2025年度 算定金額 累計121,884千円（月平均11,080千円）vs 前年度144,784千円（月平均12,065千円）
・2月は16,326千円と年度最高を記録し、前年度同月比+6,862千円
・IMRT：累計1,779件 vs 前年度2,065件（△286件）だが、2月は236件と年度最高
・体外照射：累計1,926件 vs 前年度2,546件（△620件）だが、2月は251件と回復

【補足/対策】
がん種別では乳がんの新規患者が累計147件（前年度196件）と減少が顕著。一方、肺がんは72件（前年度55件）と増加。11月に月7,588千円と大幅減があったが、2月は16,326千円と大きく回復。放射線治療管理料の算定件数も2月は25件と増加傾向にあり、今後の推移を注視。

Q5-4. 救急体制の改善状況はどうか。謝絶率は目標を達成しているか。

【結論】
救急車謝絶率は20.2%で目標30.0%を大きく上回って達成。直入率も46.4%で目標40.0%を達成している。

【根拠データ】
・資料10：
  ・救急車要請件数 累計3,603件（月平均327.5件）
  ・救急車受入件数 累計2,767件（月平均251.5件）vs 目標月280件
  ・謝絶率 平均20.2% vs 目標30.0%（前年度36.0%から大幅改善）
  ・直入率 46.4% vs 目標40.0%（前年度41.5%から改善）
・資料1-1：救急医療管理加算合計 累計3,277人 vs 前年度3,084人（+193人）

【補足/対策】
謝絶率は全月で目標を達成しており、特に9月15.8%、12月15.0%と良好。ただし救急車受入件数は月平均251.5件で目標280件には未達。受入件数の絶対数を増やすことが次のステップ。

Q5-5. 後発医薬品の使用状況は適正か。

【結論】
後発医薬品指数（数量ベース）は95.9%で目標90%を大幅に達成。金額ベース（入院）も94.1%で目標80%達成。

【根拠データ】
・資料6：後発医薬品指数（数量ベース）累計95.9% vs 目標90%
・後発医薬品使用体制加算1（47点）の要件90%以上を安定的に満たす
・資料10：後発医薬品割合 金額ベース（入院）平均94.1% vs 目標80%

・資料6：入院 金額ベース 年度推移 2022年度87.0%→2023年度87.8%→2024年度88.8%→2025年度94.1%と着実に向上
・ただし2月は入院金額ベース88.3%とやや低下

【補足/対策】
後発品のある先発医薬品の使用が多い診療科として眼科（入院303千円）、外科（219千円）、リウマチ科（190千円）が挙がっている（資料6）。個別薬剤ではアクテムラ、アナペイン、フォシーガ等が先発品として使用されており、後発品への切替可能性を検討する。

---

6. 今後の見通し・対策関連（4問）

Q6-1. 来年度に向けて最も注力すべき経営課題は何か。

【結論】
最優先課題は「外来患者数の回復」と「病床稼働率の向上」の2点。この2つで約3億円以上の収入改善が見込める。

【根拠データ】
・外来：患者数予算比△55.9人/日 x 外来単価22,628円 x 266日 ≒ 約3.4億円の機会損失
・入院：稼働率88.9% vs 予算92.0%の差（約3.1pt）x 320床 ≒ 約10床分の未活用。入院単価100,719円 x 10床 x 335日 ≒ 約3.4億円の機会損失
・資料10：紹介患者数 月平均1,150件 vs 目標1,300件（△150件/月）

【補足/対策】
具体策として: (1) 紹介元医療機関への訪問強化（現在月10.5件→15件目標）、(2) 紹介減少が大きい整形外科・消化内科・耳鼻科での地域連携強化、(3) ベッドコントロール委員会の機能強化、(4) 外来化学療法のさらなる拡充（月300件目標）を提案する。

Q6-2. マイナ保険証の利用率向上は経営にどう影響するか。

【結論】
マイナ保険証利用率は急速に向上しており（直近65.3%）、医療DX推進体制整備加算等の算定要件充足に貢献。直接的な増収効果もある。

【根拠データ】
・資料1-1/資料10：マイナ保険証利用率推移
  ・2月35.3%→4月37.9%→8月44.8%→12月65.3%（右肩上がり）
  ・年度平均44.0% vs 目標45.0%（ほぼ達成）
・直近12月は65.3%と大幅に上昇

【補足/対策】
2024年12月の健康保険証廃止に伴い、利用率は今後も上昇する見込み。医療DX推進体制整備加算の施設基準要件（マイナ保険証利用率の一定水準以上）の確保に向けて、引き続き窓口での声かけとシステム環境の整備を継続する。

Q6-3. ダヴィンチ手術の活用は順調か。更なる拡大は可能か。

【結論】
ダヴィンチ手術は月平均10.2件で目標10件を達成。安定した稼働だが、更なる拡大の余地はある。

【根拠データ】
・資料10：ダヴィンチ手術件数 累計112件（月平均10.2件）vs 目標月10件
・前年度実績 年間105件（月平均8.8件）から+1.4件/月の増加
・月別では11月12件、1月12件と2桁台後半も実現

【補足/対策】
現在のデータからは適応術式の内訳が不明。追加で診療科別・術式別のダヴィンチ使用実績データが必要。泌尿器科（累計400件の手術実績あり）や外科（900件）での適応拡大の可能性を検討すべき。ロボット支援手術は高単価であるため、件数増は入院単価の更なる向上に直結する。

Q6-4. 地域連携の弱体化を食い止めるために何が必要か。

【結論】
紹介件数の減少（月平均△102件）は組織的な取組み強化で対応すべき重要課題。特に上位紹介元との関係維持と新規紹介元の開拓が必要。

【根拠データ】
・資料7：紹介件数 累計12,652件 vs 前年度15,022件（月平均1,150件 vs 1,252件）
・逆紹介件数 累計13,225件 vs 前年度15,315件（月平均1,202件 vs 1,276件）
・資料7-2：紹介減少が大きい医療機関（3件以上減少）27施設
　・明大前クリニック △10件、放友クリニック △5件 等
・資料10：医師訪問件数 月平均10.5件 vs 目標10件（達成）
・地域医療機関からの緊急診療依頼謝絶率 11.2% vs 目標10.0%（わずかに未達）

【補足/対策】
具体策: (1) 紹介減少が顕著な27施設への集中的なフォローアップ訪問、(2) 医師訪問件数の目標を月15件に引き上げ、(3) 紹介患者の受入拒否（特にベッド満床）の解消、(4) 紹介元への迅速な診療報告書の送付（現在のデータからは送付状況不明。追加データ要）、(5) 逆紹介率が低い乳癌センター（12%）、形成外科（32%）、漢方（33%）の逆紹介推進による双方向連携の強化。

補足：現在のデータから判断できない事項

以下の項目については、今回の資料からは判断が困難であり、追加データが必要である。

No.	項目	必要なデータ
1	診療科別の収支損益	診療科別原価計算データ
2	看護師配置の充足状況	病棟別看護配置実績・7対1要件の充足状況
3	DPC機能評価係数IIの詳細	難易度・複雑性・カバー率等の各係数データ
4	医師の働き方改革への影響	医師の時間外労働実績・診療体制への影響
5	患者満足度・クレーム状況	患者アンケート結果・投書データ
6	紹介状返書の送付率・送付日数	病診連携室の返書管理データ
7	来年度の設備投資計画	中期経営計画・設備投資予算書
8	他院との機能分化の方向性	地域医療構想に基づく将来計画

本Q&A集は2025年度2月実績までのデータに基づき作成。3月実績確定後に最終版へ更新予定。